EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88618
SERVICIO : UCI HSC
FECHA : 2024-07-15 13:06:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LAURA MARCELA GARRIDO RUBIO			RUN	: 17.196.548-9
F.Nac	: 25-10-1990	Edad	: 33 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: M BUSTOS 395 P DEL SOL			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 993782912		
Fecha Ingreso	: 2024-07-12	Fecha Egreso	: 2024-07-15 13:06:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D69.6-TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

PURPURA TROMBOCITOPENIA EN ESTUDIO - OBS PTI.
INSULINORESISTENCIA.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. D69.3-PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AM: Resistencia Insulina - Obesidad
Fármacos: Metformina
Alergias: Niega

Paciente femenina 34 años, quien refiere cuadro de una semana de evolución con cefalea ocasional, malestar general y escalofríos, que 3 días previos a su ingreso se acompañan de fiebre no cuantificada y lesión petequiales en extremidades superiores e inferiores. Niega síntomas respiratorios, síntomas urinarios, gastrointestinales, neurológicos y sin otras manifestaciones de sangrado. Consulta el 12/07/2024 con petequias generalizadas, con hemograma que reporta trombocitopenia severa con 6.000pltq, sin compromiso de serie blanca o hg, VHS baja, parámetros inflamatorios bajos sin otras alteraciones en exámenes, por lo que se hospitaliza para estudio y manejo.
Se descarta foco infeccioso por lo que se inician pulsos de corticoides con dexametasona 40mg/día con mejoría progresiva de valor de plaquetas. Se mantiene 72 hrs observación en UPC, estable, sin molestias. Hemodinamia estable normotensa, en ritmo sinusal al monitor. Bien perfundida. Persiste con lesiones tipo petequias en extremidades y tronco, mayores en EEII, sin otras manifestaciones de sangrado (no epistaxis, gingivorragias, hemoptisis, hematuria, metrorragia)
Plaquetas en ascenso (6.000 → 29.000 → 73.000), sin afectación de otra serie hematológica. Test de coombs directo procesado posterior a inicio de corticoides (-). Recibe 4 días de bolo de corticoide, sin hiperglicemia. Se toma serología viral hepática negativa, HIV (-), complemento C3-C4 normal y FR negativo. Test de helicobacter pylori positivo en deposiciones. TAC-TAP sin lesiones. Pendiente resultado de estudio inmune (tomado 15/07/24) ANA, Perfil ENA, anticardiolipina, Anticoagulante lúpico, AntiDNA, ANCA, serología para virus de Epstein bar y CMV. Respiratorio sin conflicto, con fio2 21%. Afebril, parámetros inflamatorios bajos. Diuresis conservada, pruebas de funcionalismo renal y hepática sin alteraciones, buen control metabólico. Electrolitos dentro de rango, perfil tiroideo normal.

Se decide alta con HODOM para seguimiento de control de plaquetas cada 72 hrs. Traslape a corticoide oral con prednisona 80mg vía oral, disminuyendo 10 mg/ semanales. Control en poli medicina interna en 1 semana. I/C a hematología por telemedicina.

INDICACIONES AL ALTA

1. Alta con HODOM
2. Reposo relativo asistido en domicilio
3. Prednisona 80mg 4 comprimidos vo diario a las 08.00 hrs por 1 semana, luego 60mg 3 comprimidos 1 semana, y disminuir 10 mg por semana.
4. Elcal D forte 1 comprimido diario
5. Cotrimoxazol Forte 800/160mg 1 comprimido vo interdiario (lunes – miércoles – viernes)
6. Zomel HP por 14 días: Amoxicilina 1gr 1 comp cada 12 hrs | Claritromicina 500mg 1 comp cada 12 hrs | Esomeprazol 20 mg 1 caps cada 12 hrs (ayuno y precena) por 14 dias.
7. Omeprazol 20 mg vo 1 vez al día en ayunas (iniciar al termino del esomeprazol)
8. Control de recuento globular cada 72 hrs (hasta tener conteo mayor a 130mil).
9. Control en poli de Medicina interna en 1 semana con Dr. Orlando Prado (dar prioridad)
10. I/C a Hematología (Telemedicina)
11. Rescatar estudio inmune (tomados 15/07/24)
12. EDA en diferido.

Neidy Osmary Quijada de Prado
MEDICO TRATANTE
26127834-0

JEFE SERVICIO